Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II

Nº Carta Consulta: 60820
Mutuário: Estado da Bahia
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 30.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 150.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 08
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 11
2. PROJETO 12
2.1. TÍTULO 12
2.2. TÍTULO ABREVIADO 12
2.3. MUTUÁRIO 12
2.4. TIPO OPERACAO 12
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12
2.6. PROJETO/INDICADORES 12
2.7. PROJETO/COMPONENTES 13
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 19
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 20
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 20
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 21
3. FINANCIAMENTO 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 21
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 22
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 22
5. RISCOS 26
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 26
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 26
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 26
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 27
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 27
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 27

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Diagnóstico sociodemográfico

A Bahia é o quinto estado em extensão territorial, com o quarto maior contingente populacional do país. A sua população em 2018 foi estimada pelo IBGE em 14.812.617 habitantes, 72,1% deles residentes em zonas urbanas (IBGE, 2018).

De 1980 e 2015, a população do estado cresceu 60,8%. Porém, as últimas décadas apresentaram uma diminuição do ritmo de crescimento populacional. Entre os anos de 1991 e 2000, houve um crescimento populacional médio de 1,09% ao ano. Já entre 2000 e 2010, essa taxa caiu para 0,72% ao ano (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2016). As projeções apontam para uma redução ainda mais acentuada em 2018, com 0,41 e de apenas 0,10 em 2030 (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Além dessa redução na taxa de crescimento populacional, outros fatores como a redução da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida e a diminuição das taxas de fecundidade, produziram impacto importante na estrutura etária da população - processo denominado de transição demográfica.

No estado, a taxa de fecundidade decresceu em 32,8% no período de 2000 a 2018. Nas últimas décadas, o número de filhos por mulher passou de 2,49 para 1,67, sendo a média da Bahia (1,99) semelhante à do país, de 1,94 filhos por mulher. Quando se compara os 3,6 filhos/mulher registrado nas décadas de 1980/1991, esta redução foi de 53,6%. A tendência decrescente na taxa de fecundidade encontrada para o estado acompanha os índices registrados para o país e suas regiões geográficas (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Ao analisar as mudanças na estrutura etária da população entre os anos 1980 e 2018, observa-se um decréscimo de 0,5% entre os jovens com menos de vinte anos de idade. Em contrapartida, verifica-se uma acentuada elevação nas faixas etárias dos grupos populacionais com vinte anos e mais, principalmente entre os idosos com 60 anos e mais, cujo aumento foi 164, 9% (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Dos 417 municípios do estado, 57% possui menos do que vinte mil habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano do estado foi considerado médio (0,666) no estudo realizado em 2010 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Diagnóstico epidemiológico

Perfil de mortalidade

O perfil de mortalidade baiano é característico de populações que atravessaram a transição epidemiológica, com a redução das mortes por doenças infectocontagiosas e o aumento relativo das mortes por doenças crônico-degenerativas. Além disso, há o aumento das mortes por causas externas e a coexistência de óbitos por doenças infectocontagiosas, principalmente nas populações mais vulneráveis, caracterizando um perfil com uma tripla carga de doenças.

Desconsiderando-se os óbitos por causas mal definidas, em todos os anos entre 2009 e 2017, as doenças do aparelho circulatório foram as principais causas de morte no estado, correspondendo a um percentil entre 23,3% e 24,9% dos óbitos (dependendo do ano considerado). Já as causas externas foram a segunda causa de morte, oscilando entre 14,7% e 16,5%. Em terceiro lugar figuram as neoplasias, com uma tendência de crescimento no período, passando de 11,9% a 13,8%. A seguir, aparecem as doenças do aparelho respiratório, com uma estabilidade no período, oscilando entre 7,2% e 8,3%. Ocupando o quinto lugar das principais causas de óbito, estão as doenças endócrinas, com um discreto aumento de 7,1% a 7,8% (Gráfico 1 - Anexo 4).

Há que se destacar que no período houve uma melhora na investigação das causas de óbito. Em 2009, 13,6% dos óbitos foram por causas mal definidas, proporção que sofreu uma redução discreta, indo a 12,6% no final do período.

Dentre as doenças do aparelho circulatório, as doenças isquêmicas do coração (incluindo o infarto agudo do miocárdio) e as doenças cerebrovasculares apresentaram uma elevação de suas taxas de mortalidade, indicando um maior risco de morte por essas doenças (Gráfico 2 - Anexo 4), principalmente após os 50 anos de idade.

Em 2017, as doenças cerebrovasculares apresentaram uma taxa de mortalidade de 44,7 óbitos por 100 mil habitantes. As doenças isquêmicas do coração apresentaram, nesse mesmo ano, uma taxa de 39,0 por 100 mil habitantes.

Em relação às causas externas, observou-se um aumento considerável do risco de morte por homicídios e por acidentes de trânsito. De 2009 a 2017, a taxa de mortalidade por homicídios passou de 36,9 óbitos por 100 mil habitantes para 44,9 ?um aumento de 12,5%. Já os acidentes de trânsito passaram de 13,2 para 15,6 óbitos por 100 mil habitantes, um aumento de 18% (Gráfico 3 - Anexo 4).

Desagregando-se os óbitos por acidentes de trânsito, temos um aumento do risco de morte por acidentes de motocicletas que passou de 0,7 óbitos por 100 mil habitantes em 2000, para 4,6 em 2017 ?um crescimento de 557% (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Quantos aos homicídios, o meio predominante utilizado pelos agressores foram as armas de fogo, a taxa de mortalidade por homicídios por armas de fogo alcançou 35,4 óbitos por 100.000 habitantes no ano de 2017, o que representou um crescimento de 18,4%, em relação a 2009, quando esta taxa foi de 29,9 óbitos por 100.000 habitantes (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Como ressaltado anteriormente, as neoplasias foram a terceira principal causa de morte no período. O câncer de mama, na população de mulheres, além de ser o mais frequente é o que apresenta o maior risco de morte. Em 2017, esta neoplasia apresentou a maior taxa no período, com risco de 12,7 óbitos por 100.000 mulheres. Para os homens, o câncer com o maior risco de morte foi o de próstata, alcançando em 2017 a taxa de 17,5 óbitos por 100.000 homens (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Internações hospitalares

Excluindo-se as internações relacionadas à gravidez, parto e puerpério, de 2009 a 2017, as doenças do aparelho respiratório foram as principais causas de internação na Bahia, correspondendo a 15,7% das internações em 2009 e 10,4% em 2017. No segundo lugar, ficaram as doenças infecciosas e parasitárias, responsáveis por 14,3% das internações em 2009 e 8,4% em 2017. A seguir, temos as doenças do aparelho digestivo e as doenças do aparelho circulatório com percentis de internação muito próximos. Em 2009, as doenças do aparelho digestivos eram responsáveis por 8,7% das internações, passando a 9,8% em 2017. Já as doenças do aparelho circulatório, eram responsáveis por 8,1% das internações em 2009, passando a 8,4% em 2017. Por fim, aparecem as causas externas, com 5,9% das internações em 2009 e 9,0% das internações em 2017; e, as internações por neoplasia com 4,0% em 2009 e 6,0% em 2017 (Gráfico 4 - Anexo 4).

Entre os menores de um ano, as principais causas de internação são as afecções originadas no período perinatal, as doenças do aparelho respiratório e as doenças infecciosas e parasitárias. Na faixa etária dos 1 aos 9 anos, as doenças do aparelho respiratório e as doenças infeciosas e parasitárias continuam sendo as principais causas de internação, seguida das doenças do aparelho digestivo. (Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), acessado em 07.06.21).

Entre os adultos ate 49 anos do sexo masculino, as principais causas de internação, de 2009 a 2017, foram as causas externas. No grupo entre 50 e 59 anos, as doenças do aparelho circulatório e digestivo são as principais responsáveis pelas internações, entretanto as causas externas figuram como terceira principal causa nesse grupo etário (Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), acessado em 07.06.21).

A análise das internações no sexo feminino revela que as principais causas na faixa etária de 20 a 49 foram as doenças do aparelho geniturinário, digestivo e as neoplasias. Ja entre mulheres de 50 a 59 anos, as doenças do aparelho circulatório ocupam a primeira causa de internações, seguida das doenças do aparelho digestivo e neoplasias, em terceiro lugar (Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), acessado em 07.06.21).

Para a faixa etária a partir dos 60 anos, as doenças do aparelho circulatório e as doenças do aparelho respiratório são as principais causas de internação para ambos os sexos (Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), acessado em 07.06.21).

Doenças redutíveis por imunização

A maioria das doenças redutíveis por imunização observaram uma diminuição de sua incidência, com exceção da hepatite de tipo B que registrou um aumento de 88,7%. Tal aumento pode ser o reflexo de um maior acesso ao diagnóstico através de exames sorológicos específicos, mas não exclui a possibilidade de um aumento da transmissão sexual (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2016).

HIV/Aids e Sífilis Congênita

No que diz respeito a Aids e ao HIV, foram notificados, no período de 2009 a 2018, 18.287 casos de aids e 15.567 casos de HIV. A taxa de detecção da aids (por 100 mil habitantes), no mesmo período, apresentou decréscimo, sobretudo a partir de 2011, com apenas 13,7 casos abaixo da taxa nacional (22 por 100 mil habitantes). A partir de 2014, observa-se um aumento da incidência dos casos de HIV, ano que se tornou obrigatória a notificação dos casos confirmados. Destaca-se que em 2013 foi implementado o tratamento para todas as Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV), independentemente da carga viral, o que tem contribuído para a redução dos casos de aids no estado (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

A sífilis congênita (SC) é uma doença de elevada magnitude e transcendência, passível de controle desde que as mulheres com sífilis sejam diagnosticadas e tratadas adequadamente durante a gestação. A prevenção da transmissão vertical da sífilis é uma prioridade da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, em parceria com Ministério da Saúde (MS), em observância às orientações da Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), para atingir a taxa de incidência de sífilis congênita menor ou igual a 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

De 2009 a 2018, a taxa de incidência de sífilis congênita na população menor de um ano, variou de 1,2 casos/1000 nascidos vivos em 2009 a 6,6 casos/1000 nascidos vivos em 2018, apresentando crescimento semelhante ao observado no país (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Concernente a mortalidade, na série histórica de 2009 a 2018, registrou-se 81 óbitos por SC em menores de 1 ano de idade de residentes na Bahia. O coeficiente de mortalidade variou de 0,5/100.000 nascidos vivos em 2010 a 8,3 óbitos/100.000 nascidos vivos em 2014, quando apresentou o maior coeficiente, cenário este de curva ascendente semelhante ao do Brasil (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Doenças de transmissão vetorial

As doenças de transmissão vetorial têm apresentado perfil de difícil controle no estado da Bahia, sendo as mesmas responsáveis na última década pela elevada morbimortalidade e sobrecarga nos sistemas de saúde. O fortalecimento de estratégias que colaborem com a integração entre as vigilâncias e rede assistencial torna-se imprescindível para desenvolvimento de ações articuladas e coordenadas direcionadas à prevenção e controle dos agravos relacionados à transmissão vetorial, incluindo o uso de agrotóxico em ações de saúde pública para combate ao vetor da dengue. Destaca-se a importância da atenção básica/ primária em saúde, tendo em vista o desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e controle da doença, pelas equipes de saúde da família, agentes de saúde e os agentes de endemias, no território que atuam. A dengue é a mais importante arbovirose que afeta o homem. Na Bahia, os anos de 2009, 2013 e 2016 foram os que mais notificaram número de casos. Em 2009, foi registrada a maior epidemia desde a reintrodução da doença no estado, ocorrendo 96.651 casos notificados com coeficiente de incidência (CI) de 660,30/100 mil habitantes. Nos dois últimos anos da série histórica, 2017 e 2018, o estado apresentou redução dos coeficientes de incidência, respectivamente, 64,06 e 63,12/100 mil habitantes (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Outra arbovirose de relevância epidemiológica diz respeito à chikungunya (CHIKV). Em 2017, foram notificados 11.135 casos de Chikungunya, no estado da Bahia, ao passo que em 2018 foram 4.368, ocorrendo uma redução de 154,9% dos casos notificados. Com relação a faixa etária e sexo, o ano de 2017 apresentou comportamento semelhante ao ano de 2018. Neste último, a faixa etária mais atingida foi de 30 a 39 anos (858 casos/100.000 habitantes), correspondendo a 19,6% dos casos, seguida pelas faixas de 20 a 29 anos (761 casos/100.000 habitantes) com 17,2% e de 40 a 49 anos (654 casos/100.000 habitantes), representando 14,9% das notificações. Do total de casos notificados, 62,4% são do sexo feminino. Sobre a mortalidade, no período de 2014 a 2017, foram confirmados 15 óbitos por chikungunya. Os anos com o maior registro foram 2015 (6 casos) e 2016 (5 casos) (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Quanto ao vírus Zika, no período de 2015 a 2018, foram registrados 97.893 casos suspeitos de Zika, dos quais 58,9% concentraram-se no ano de 2016, com coeficiente de incidência (CI) de 379,21 casos/100 mil habitantes, sendo esse o ano mais epidêmico da doença. A partir de 2017, observou-se decréscimo no número de casos e no coeficiente de incidência, ratificando a característica cíclica da arbovirose. Em 2018, 67,2% das notificações foram de pessoas do sexo feminino, e do total de notificações para o mesmo período, 39,1% correspondem a faixa etária de 20 a 39 anos. Esse dado é de fundamental importância para saúde pública, visto que a faixa etária mais acometida foi a de população economicamente ativa e de mulher em idade fértil, fator que predispõe ao aumento de casos em gestantes e , consequentemente, aumento de registro de casos de microcefalia (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Com relação às complicações relacionadas à infecção pelo vírus Zika durante a gestação - microcefalia e Síndrome Congênita do Zika vírus - SCZv - no acumulado de 2015 a 2018, constam no Registro de Emergência em Saúde Pública notificações de casos de pacientes residentes em 252 municípios do estado, atingindo todas as Macrorregiões de Saúde, totalizando 1.885 casos, destes, 29,2% com confirmação diagnóstica. O maior número de casos notificados tem como residência municípios da Macrorregião Leste (58,5%), seguida da Centro-Leste (9,7%) (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Doença falciforme

Em 2009, a doença falciforme foi incluída no rol doenças de notificação compulsória do município de Salvador. No período de 2009 a 2015 , foram registrados 1.643 casos da enfermidade (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2016).

Mortalidade materna

No estado da Bahia, a razão de mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos) passou de 91,6 óbitos em 2009, para 65,6 óbitos em 2017 (-28,5%). A razão de mortalidade materna, no estado da Bahia, ainda está aquém do esperado, considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece como aceitável a razão de mortalidade materna (RMM) de até 20 óbitos por 100.000 nascidos vivos (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Quanto à mortalidade segundo o tipo e principais causas, a análise da série histórica demonstrou que em todos os anos houve o predomínio das causas diretas, com destaque para as eclâmpsias e infecções puerperais, quando comparadas com as indiretas, principalmente a Aids e as doenças do aparelho circulatório. Nas causas diretas, notou-se que houve variações entre os anos, sendo a maior RMM em 2014 (52,3) e a menor em 2016 (39,0). Quanto as causas indiretas, estas apresentaram tendência de queda no período analisado, reduzindo 53,7% de 2009 para 2017 (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

O novo contexto a partir da Pandemia de SARS-Cov-2

Em 11 de Março de 2020 foi anunciada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, em Genebra, reconheceu que o Novo Coronavírus tinha proporções Pandêmicas. Considerando o cenário mundial do novo coronavírus (COVID-19), em que foi detectado inicialmente na China em 31 de dezembro de 2019, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia iniciou o processo de articulação das ações de vigilância em saúde e organização da rede de atenção desde janeiro de 2020, visando preparar resposta coordenada para enfrentamento da possível ocorrência de casos na Bahia. Desde esta data, vimos os números avançarem e acometerem milhões de pessoas (06/06/2021), com uma perspectiva mórbida, que levou-nos a refletir sobre nossos hábitos, nossas relações e formas de assistir as pessoas.

Na Figura 1 (Anexo 4) que segue, podemos ver um resumo do que chegamos até a data de 15 de julho de 2021 e na Figura 2 (Anexo 4) subsequente, o seu avanço semana a semana, desde o primeiro caso detectado em 06 de março de 2020.

No mapa (Anexo 4) podemos ver a disseminação do Vírus SARS-Cov-2, em uma distribuição espacial no Estado da Bahia, que atinge 100 % dos Municípios.

A partir deste novo contexto, imposto pela Pandemia da COVID19, o Governo do Estado precisou direcionar prioritariamente recursos para responder a situação de emergência de saúde, dentre eles, abertura de leitos de UTI, abertura de Hospitais para atendimento exclusivo ao COVID19, ampliação do Laboratório Central do Estado - LACEN, contratação de Unidades Móveis de porte avançado, ampliação do serviço de UTI aérea, entre outros.

Além destas estruturas e ações, também foi muito importante as ofertas à distância voltadas para trabalhadores e gestores, bem como a ampliação da Telessaúde, este último ficando como um legado para a Saúde e uma perspectiva de solidificação de uma estratégia inovadora para garantir assistência de forma segura, com resolutividade, ampliação do acesso e eficiente.

A Rede de Serviços do SUS Bahia e seus principais desafios

O Sistema Único de Saúde é reconhecido como uma grande conquista da população brasileira por ser uma política pública de saúde que garante acesso universal, integral e equânime, considerando as particularidades de indivíduos e suas populações. Seus princípios organizativos são a descentralização dos serviços; a regionalização e hierarquização da rede; e a participação social, que representam a forma de organização e operacionalização do sistema.

Dessa forma, o Sistema Único de Saúde do estado da Bahia se caracteriza como exemplo no país por prover acesso a serviços de saúde em um dos maiores estados em extensão territorial, com uma população de mais de 14 milhões de habitantes (7,1 % do país).

De acordo com a divisão político-administrativa, abrange 417 municípios, tendo como capital a cidade de Salvador, situada na macrorregião Leste e que representa 19,3% do total de habitantes do estado. Sua divisão na área da saúde se dá por meio de 28 regiões de saúde, que se aglutinam em 9 macrorregiões, também conhecidas como Núcleos Regionais de Saúde, conformando o desenho territorial resultante do Plano Diretor de Regionalização-PDR.

Em relação à assistência, cabe à Secretaria Estadual da Saúde da Bahia (SESAB) a oferta de atendimento de baixa, média e alta complexidade, ou seja, assistência envolvendo ações como cuidados de saúde primários, diagnósticos, tratamentos clínicos e tratamentos cirúrgicos, reabilitação, acompanhamento pré e pós-operatório, oferta de imunobiológicos e Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Nesse sentido, a SESAB possui uma rede de unidades de saúde que envolve Hospitais, Maternidades, Unidades de Pronto Atendimento 24h e de Emergência e Centros de Referência. No total, a Rede SESAB conta com 54 unidades de saúde de alta e média complexidade, distribuídas em toda a Bahia. São 13 Hospitais na capital, 23 Hospitais no interior e 18 Policlínicas espalhadas pelo território baiano.

As Unidades Básicas de Saúde, assim como as ações de Atenção Básica, são de responsabilidade dos municípios. Estão entre elas Postos de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Saúde da Família e ações de promoção da saúde mental e prevenção de doenças. Em todo o estado, são 3.693 Unidades Básicas de Saúde, entre Equipes de Saúde da Família e Equipes de Atenção Primária que recebem incentivo financeiro da SESAB mensalmente, através dos fundos municipais de saúde.

Na perspectiva de estruturar uma Rede de Atenção à Saúde tendo a Atenção Básica como ordenadora da rede, coordenadora do cuidado de forma resolutiva e ascendente o Estado da Bahia adotou como estratégia a implantação das Policlínicas Regionais de Saúde, por meio de Consórcios Interfederativos, atuando de forma complementar à Atenção Básica.

Para tanto, seu ordenamento se dá por meio de protocolos de acesso para a Policlínica, em que trabalhadores da Atenção Básica participam de capacitação para que possam realizar o compartilhamento de casos com especialistas e solicitação de exames complementares com critérios técnicos.

O acesso a exames e consultas especializadas faz com que o usuário tenha sua condição de saúde melhor investigada pela Atenção Básica e sua conduta complementada por especialista da Policlínica. E, com isto, consiga-se avançar não só na estruturação de uma Rede Assistencial, mas na garantia de direito à integralidade assistencial.

Existem ainda os Centros Estaduais de Referência, unidades da rede SUS que prestam atendimento a públicos ou situações específicas, através da assistência propriamente dita ou, em determinados casos, oriundos da atenção básica. Estas unidades também se constituem em campo de pesquisa em suas áreas, sendo eles: (i) Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - CRE-TEA, (ii) Centro de Referência Estadual para Assistência ao Diabetes e Endocrinologia - Cedeba, (iii) Centro de Informações Antiveneno - Ciave, (iv) Centro de Atenção à Saúde do Idoso - Creasi, (v) Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Cepred, (vi) Centro de Referência em Doenças Endêmicas - PIEJ, (vii) Centro Estadual de Oncologia - Cican, (viii) Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa - Cedap (antigo CREAIDS) e (ix) Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - Cesat.

Em relação à Atenção à Saúde Mental no estado, esta é orientada pelo Plano de Desinstitucionalização da Bahia, garantindo proteção aos direitos das pessoas com transtornos mentais, enfatizando a importância da garantia do cumprimento dos direitos deste público, e redirecionando o modelo assistencial em saúde mental. Assim, o estado propõe a substituição progressiva do modelo de atenção hospitalocêntrico, o qual exclui as pessoas com transtorno mental do convívio social, para um modelo de atenção de base comunitária de modo programado e responsável, envolvendo esforços dos três entes: Municípios, Estado e União, a partir da execução de ações em dois níveis: (i) a substituição progressiva da assistência nos hospitais psiquiátricos pela assistência nos pontos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e (ii) a implementação efetiva da RAPS em todo o Estado.

O acesso do paciente à realização de exames ou avaliação médica especializada, requer, muitas vezes, que seja providenciada a transferência do paciente, sendo que a estratégia estadual do Saúde Sem Fronteiras conta com os serviços móveis de Mutirão de Cirurgias, rastreamento do câncer de mama (mamografia), oftalmologia, odontologia (Odontomóvel) e doação de sangue (Hemóvel).

Mais especificamente, O Hospital da Mulher possui uma unidade itinerante de atendimento que percorre todo o território baiano, atendendo mulheres para a realização do preventivo e de mamografia. A unidade é uma importante aliada no combate do câncer de mama e do colo do útero e é equipada com dois consultórios ginecológicos e um mamógrafo.

Outro importante serviço itinerante são os Hemóveis, que são unidades móveis que se deslocam para regiões com grande fluxo de pessoas, possibilitando a doação de sangue. Atualmente o estado possui 2 (dois) Hemóveis, sendo que cada um tem capacidade para coletar 120 bolsas de sangue em jornada de oito horas, além de fazer o cadastro para a doação de medula óssea. Uma amostra do DNA do doador vai para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e, em caso de compatibilidade com algum paciente, o transplante é realizado. Em nível de captação, as unidades móveis superam 23 das 24 unidades de coleta no estado.

O estado conta também com o Laboratório Central de Saúde Pública Profº Gonçalo Moniz - LACEN/Ba, com seus 105 anos de história, reconhecido como a 3ª maior unidade de vigilância laboratorial do país, classificado na categoria máxima de qualidade pelo Ministério da Saúde. O LACEN/Ba compreende um conjunto de ações transversais aos demais sistemas de vigilância em saúde, propiciando conhecimento e investigação diagnóstica de agravos e verificação da qualidade de produtos de interesse para a saúde pública, mediante estudo, pesquisa e análises relacionados aos riscos epidemiológicos, sanitários, ambientais e da saúde do trabalhador, além de coordenar a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública -RELSP na Bahia.

Atualmente, a RELSP é composta de 25 (vinte e cinco) laboratórios, sendo: 01 (uma) Unidade Central, com gestão estadual; 12 (doze) laboratórios descentralizados de vigilância epidemiológica, sendo: 11 (onze) Laboratórios Municipais de Referência Regional (LMRR), com gestão compartilhada entre Estado e Município, e 01 (um) Laboratório Estadual de Referência Regional (LERR), com gestão estadual e 12 (doze) Laboratórios Regionais de Vigilância da Qualidade da Água (LVQA), gerenciados pelos Núcleos Regionais de Saúde, sendo 02 (dois) em parceria com universidades, a saber: Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC (Ilhéus) e Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB (Barreiras), 01 (um) no LMRR de Senhor do Bonfim e 01 (um) no LERR de Jequié.

A Rede Frio do estado da Bahia é um sistema amplo, que inclui estrutura técnico-administrativa vinculada aos Núcleos Regionais de Saúde e orientada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento que visa à manutenção adequada da cadeia de frio, que é o processo logístico de conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais.

Nota-se, que apesar do grande número de serviços e da oferta e acesso a bens de saúde no estado, ainda existem alguns problemas a serem enfrentados. Na atenção especializada, observam-se: (a) deficiências na regulação médica do paciente da rede de atenção primária para a rede de atenção especializada; (b) dificuldades de comunicação ao paciente da marcação da sua consulta e/ou exame especializado; (c) dificuldades no deslocamento do paciente aos serviços especializados fora do local de sua residência (ou mais afastado dela); (d) deficiência na oferta especializada regional; (e) dificuldade de deslocamento/fixação de profissionais especializados no interior do Estado; (f)dificuldade de flexibilização de carga horária/cumulação de vínculos.

Percebe-se também problemas organizacionais que prejudicam a cobertura da rede e que impactam na atenção básica, como a falta de integração entre os serviços e níveis de atenção, favorecendo a fragmentação dos cuidados, dificuldades no acompanhamento dos casos crônicos, incapacidade de atuação adequada por falta de padronização. Acredita-se que com a capacitação de profissionais em protocolos de atendimento, que se implantados, poderiam reduzir internações desnecessárias e ampliar as vagas para os casos de urgência e emergência, bem como os casos cirúrgicos.

Na saúde mental, esforços para ampliação e fortalecimento da RAPS com a construção de CAPS III, CAPS AD, CAPS I, Unidade de Acolhimento Infantil e Adulto em Saúde Mental (UA) e leitos de saúde mental no Hospital Metropolitano e a capacitação dos profissionais da rede são extremamente necessários, especialmente por conta do contexto da pandemia do COVID-19, que tem gerado aumento de demanda de atendimento em saúde mental.

É importante destacar os desafios persistentes de operacionalizar o SUS em um estado, especialmente quando entende-se a necessidade de se efetivar a integralidade como o centro do processo, considerando as condições históricas e socioeconômicas de cada região e a garantia de acesso universal. A formatação de um padrão de integralidade para o atendimento na Bahia pressupõe: ambiência (modelo arquitetônico); tecnologia e informação; insumos (medicamentos e materiais médico-hospitalares) e exames; equipe; oferta de serviços e por fim, organização produtiva do trabalho.

Assim, em 2014 foi firmado o Contrato de Empréstimo entre o Governo do Estado da Bahia e o BID para o Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Salvador - PROSUS. Nele realizou-se a estruturação da Atenção Integral à Saúde para superação dos vazios assistenciais em áreas prioritárias da Região Metropolitana de Salvador (RMS); fortaleceu-se a Regulação da Assistência à Saúde garantindo o acesso adequado dos usuários do SUS aos serviços disponibilizados na RMS; e promoveu o fortalecimento Institucional da SESAB consolidando o papel de coordenador geral do Sistema Estadual de Saúde. Essas ações se deram por meio da construção e implantação de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 13 Policlínicas de Saúde; 14 Academias da Saúde; 09 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 01 Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil (UAIJ); 01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); construção do Hospital Metropolitano, ampliação e reforma do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e do Hospital João Batista Caribé que passou a se chamar Maternidade Maria Conceição de Jesus; superando parcialmente os vazios assistenciais; além de promover o fortalecimento institucional através de capacitações para toda a rede SUS da RMS e gestores da SESAB. Foi também estabelecido pelo PROSUS I a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão. O sistema que foi cedido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chamado AGHUse - Sistema de Acompanhamento e Gestão Hospitalar, implantado e utilizado em 8 serviços de referência do estado até o momento.

Dessa forma, visando o contínuo e necessário fortalecimento do SUS do estado da Bahia, e a ampliação das experiências exitosas do PROSUS I na RMS para as demais regiões do estado, serão propostas algumas soluções parte do desenho do Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Solução Proposta

Para fazer frente aos problemas apresentados propõe-se com o Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II a ampliação do acesso, o aumento da resolutividade e melhoria da qualidade dos serviços de saúde, bem como a qualificação da gestão através de um processo de informatização de toda a rede para as demais regiões da saúde do estado da Bahia.

Devido a escassez de recursos financeiros imprimidos pelo contexto atual da pandemia da COVID-19 e de sua consequente crise econômica, garantir saúde de qualidade, eficaz e com otimização dos custos se faz necessário.

A seguir, apresentaremos as soluções propostas ao enfrentamento do diagnóstico situacional apresentado por tópicos:

Atenção Básica

Apesar do avanço na cobertura da população do estado pela Estratégia de Saúde da Família - ESF, ainda há municípios cuja cobertura é inferior a 70%. Para além disto, temos ainda municípios com Equipes da ESF atuando em Unidades precárias e/ou alugadas, o que acarreta uma instabilidade da permanência da ESF e uma baixa qualidade assistencial. É imprescindível, portanto, a ampliação da sua cobertura para que a Atenção Básica priorize os Municípios com menos de 70% de cobertura, bem como, substituir as estruturas alugadas por Unidades próprias, para que a Atenção Básica possa se consolidar e assumir o papel de coordenação do cuidado e ordenação das Redes de Atenção à Saúde.

Além da ampliação do acesso à Atenção Básica, é necessário que esta seja resolutiva, estabeleça vínculo e se torne referência para as pessoas, coordene o cuidado e estabeleça o itinerário terapêutico do usuário na Rede de Atenção à Saúde. Por isso, o Projeto prevê também um investimento tecnológico que permita otimizar as ações da Atenção Básica gerando também, com isso, informações que subsidiem a tomada de decisão por parte da gestão e o acesso a tecnologias de telessaúde para a qualificação da assistência e para a regulação inteligente dos serviços especializados.

Telessaúde:

No que tange ao Telessaúde, cabe ressaltar que o Estado da Bahia possui o Núcleo Técnico Científico desde 2012. Criado a partir de um Projeto da Secretaria de Gestão do Trabalho Ensino e Serviço do Ministério da Saúde, em 2005, a Bahia só veio a aderir em 2011, desde então, já são mais de 14.235 profissionais cadastrados na Plataforma, em 3.637 Unidades Básicas de Saúde dos 417 Municípios da Bahia .

Dentre as ofertas consolidadas realizadas pelo Núcleo de Telessaúde da Bahia, podemos ressaltar:

Tele-educação - voltada para educação continuada, tem uma abrangência em todo o Estado. Tem um amplo acesso de trabalhadores de todas as áreas da saúde. Existe uma ampla agenda semanal e pode ser acessado via canal do You Tube, Plataforma da Rede Nacional de Pesquisa e Zoom.

Teleconsultoria - foi a precursora do Núcleo e que possibilita a discussão de casos, envio de materiais educativos de forma síncrona e assíncrona pela Plataforma do Telessaúde Bahia. Atualmente também é realizada Teleconsultoria Especializada, com parcerias com o Centro Estadual de Diabetes e Endocrinologia da Bahia ? CEDEBA, Centro de Câncer da Bahia e Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA, bem como Telerregulação ao CEDEBA e Teleconsulta com a Faculdade de Medicina/UFBA.

Telediagnóstico - estruturado a partir da oferta nacional de telediagnóstico do MS, a SESAB oferece para os Municípios Baianos Telediagnóstico em ECG e Dermatologia. Estes exames são realizados na sua grande maioria em Unidades Básicas e auxiliam a um menor deslocamento dos Usuários e ampliação da resolutividade dos casos. Atualmente já são mais de 150 mil laudos realizados e presença em mais de 200 municípios.

Durante a Pandemia todas as ofertas do Núcleo de Telessaúde da Bahia foi potencializado, visto que é uma ferramenta de gestão que possibilita assistir de forma segura, com todos os aspectos éticos garantidos, resultando em uma redução de custo, ampliação da resolutividade assistencial, ampliação do acesso e potencialização das ações de Educação Permanente em meio às restrições impostas pela Pandemia.

Desta forma, a ampliação e qualificação das ofertas, via Núcleo de Telessaúde da Bahia possibilitará o ordenamento da rede a partir da Atenção Básica e a estruturação da Assistência Remota (Teleconsulta) em todos os níveis e com maior amplitude, bem como a organização do acesso no nível ambulatorial especializado.

Média e Alta Complexidade:

No tocante aos outros níveis do sistema de saúde, o Projeto visa a descentralização e regionalização das ações de média e alta complexidade, através do fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde.

Planeja-se a criação de Centros Estaduais de Referência nas áreas de Anemia Falciforme e outras Hemoglobinopatias, Hipertensão Arterial e Aterosclerose, Feridas e Pé Diabético, além da ampliação, em todo o estado, de Policlínicas, CAPS III e AD III, Centros Especializados em Reabilitação, salas de atendimento ao portador de pé diabético, hospitais e maternidades regionais, Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia.

A ampliação de 3 Policlínicas, 20 CAPS, 15 CER e 40 novos leitos de UTI e Semi-Intensiva se justificam não só pela continuidade das ações do PROSUS I, alcançando assim todo o estado, mais também devido as necessidades decorrentes da pandemia da COVID-19, que demandam tanto acesso a serviços de alta complexidade, mas também apoio em saúde mental e reabilitação dos pacientes com sequelas da doença.

Também pretende-se investir nos serviços de apoio diagnóstico como as Carretas da Saúde da Mulher com Mamógrafos e consultórios ginecológicos, além dos Hemóveis para captação de doadores de sangue.

Informatização do SUS Bahia:

A diretriz de modernização tecnológica também se estende à média e à alta complexidade através da ampliação da conectividade de todos os hospitais municipais, estaduais e filantrópicos e da continuidade da implantação do prontuário eletrônico nas unidades de saúde sob gestão estadual.

Importante destacar que a falta de um sistema de informação padrão que gerencie o atendimento realizado à população e os fluxos de processos assistenciais e administrativos, nas unidades de saúde sob gestão da SESAB, trazem prejuízos ao Estado, na demora ao acesso dos dados e informações importantes a alta gestão, além dos prejuízos operacionais no funcionamento dos próprios estabelecimentos de saúde.

Outro ponto importante a destacar é a certificação digital dos profissionais de saúde para que possam assinar digitalmente com validade jurídica documentos eletrônicos, como prescrições de medicamentos, atestados e laudos. Além de comprovar a identidade para acessar sistemas eletrônicos restritos, principalmente de órgãos públicos.

A qualidade da assistência dos serviços de saúde e da gestão da rede é outro componente essencial para a melhoria da saúde da população e para a resolução dos problemas identificados. Para isso, haverá o investimento na certificação e acreditação das Policlínicas e dos hospitais sob gestão estadual, bem como a implementação de sistemas de gestão e a capacitação dos gestores da saúde.

Dentre os potenciais impactos, está a melhoria do gerenciamento hospitalar e da qualidade da assistência prestada aos usuários. Além disso, a adoção voluntária de padrões de qualidade potencializa o reconhecimento público do hospital acreditado.

Tudo isso porque, os vários padrões disponíveis são baseados em áreas do gerenciamento hospitalar, que abrangem os princípios de garantia de qualidade, prática baseada em evidências, ética médica e segurança do paciente. Com efeito, é um meio estratégico para ajudar os serviços a aproveitarem ao máximo seus recursos e gerenciarem custos, e os pacientes e profissionais são os maiores beneficiados de uma acreditação hospitalar, pois ganham em segurança.

Núcleos de Saúde, Rede de Frios e Laboratório Central de Saúde Pública:

Com o advento da pandemia da COVID-19, a reestruturação dos Núcleos Regionais de Saúde para comportar as Redes Frios do estado e dos Lacens se fazem necessários para adequação da oferta de serviços prestados, na garantia da adequada imunização dos baianos, além de sua testagem e monitoramento de doenças.

Resultados Esperados

Os resultados esperados com a implementação deste programa são os seguintes:

Qualificar a gestão hospitalar;

Ampliar a implantação de prontuário eletrônico na rede;

Ampliar o acesso aos serviços primários, secundários e terciários da rede de atenção nas regiões da saúde do estado;

Otimizar a alocação de recursos humanos dos serviços do estado;

Ampliar a capacidade diagnóstica (laboratorial e de imagem);

Ampliar o acesso a serviços através das ações do Núcleo de Telessaúde da Bahia;

Capacitar gestores e profissionais de saúde.

Sustentabilidade

As ações propostas por este Programa para melhoria do sistema de saúde do estado da Bahia foram pensadas considerando os custos adicionais ao sistema, mas que ao fim racionalizam e reorganizam a assistência trazendo maior custo-efetividade e benefícios a população.

O Projeto de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS I foi responsável por garantir a expansão da rede de atenção à saúde para toda a região metropolitana. A necessidade de se garantir acesso aos serviços de saúde e aos cuidados integrados para todas as regiões do estado da Bahia justifica a necessidade do PROSUS II.

Ele será responsável pela ampliação da infraestrutura da rede de atenção à saúde por meio de novas Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Policlínicas, Centros Especializados de Reabilitação e Leitos de Unidade de Terapia Intensiva, além das reformas e ampliações propostas na Rede Frio e Lacens.

Os investimentos em tecnologia da informação e comunicação (TIC) se fazem necessários para modernização dos serviços, e dos processos de trabalho, para um maior apoio a tomada de decisão e também maior custo-efetividade das ações, que ao fim, racionalizam e reorganizam a assistência trazendo maior custo-efetividade.

Os investimentos aqui propostos serão duradouros, pois muitos deles fazem parte da gestão por meio dos Consórcios Interfederativos de Saúde, que consistem na junção de municípios por Regiões de Saúde do estado, para unir esforços e dividir os custos com a assistência à Saúde de seus habitantes. Esse modelo de gestão visa ampliar a assistência de saúde da média e alta complexidade nos municípios baianos, possibilitando que o cidadão tenha um atendimento de qualidade de média complexidade, com a oferta de consultas de diversas especialidades médicas e a realização de exames de imagem e outros em policlínicas. Além disso, prevê a adequação e melhoria de hospitais e outras unidades de saúde voltadas para fazer o atendimento também de alta complexidade. Tudo isso com o objetivo de ser perto de casa, para que o paciente não precise se deslocar longas distâncias para conseguir atendimento.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações Estratégicas

As ações descritas nesse projeto estão em linha com o Plano Estadual de Saúde 2020-2023 (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019), em especial com os seguintes compromissos:

Compromisso 2 - Fortalecer a Atenção Básica de forma integrada e resolutiva. O Projeto contribuirá com a consolidação da Atenção Básica, através da ampliação do acesso e de sua resolutividade, da qualificação do cuidado e da gestão, bem como através do fortalecimento de seu papel de coordenação do cuidado centrado nas necessidades das pessoas.

Compromisso 3 - Potencializar a Rede de Atenção à Saúde - RAS de forma regionalizada, ampliando a equidade de acesso, garantindo a integralidade e a segurança do paciente. O Projeto contribuirá com a melhoria da cobertura assistencial, a qualificação das ações e dos serviços de saúde, a ampliação do acesso e da regulação da oferta da atenção especializada.

Compromissos 4 - Promover a valorização do trabalho e do trabalhador no SUS/BA. O projeto visa contribuir para a capacitação de profissionais de saúde e gestores de forma a capacitar e valorizar o trabalho, promovendo estratégias para reorientar o sistema e os serviços, segundo a lógica da promoção da saúde e contribuir com a melhoria da gestão e do cuidado.

Compromisso 5 - Potencializar a Atenção Hematológica e Hemoterápica à população da Bahia. As ações do projeto visam potencializar a atenção hematológica e hemoterápica à população baiana, para a produção e fornecimento de hemocomponentes com qualidade e em quantidade suficiente ao atendimento da demanda da rede de saúde do Estado da Bahia.

Compromisso 6 - Fortalecer a capacidade de gestão estadual do SUS, qualificando as ações de sistematização, monitoramento e fiscalização, ampliando os canais de diálogo com a sociedade e o exercício do controle social. O Projeto contribuirá com o aperfeiçoamento da gestão do sistema, o desenvolvimento de processos de planejamento com base nas necessidades de saúde da população, a organização de serviços, o planejamento regional integrado e a transparência da gestão do sistema.

Contrapartida

A contrapartida do Estado da Bahia para o Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - Prosus II está de acordo com o disposto na Resolução COFIEX nº 2 de 05/09/2017, sendo no valor de US$ 30.000.000,00, correspondendo a pelo menos 20% do valor total do programa. Este valor da contrapartida deverá ser aplicado na gestão das unidades construídas com recursos PROSUS II, principalmente, no Hospital Metropolitano e Policlínicas Regionais de Saúde.

Taxa de Câmbio

A taxa de câmbio adotada como valor de referência é de U$ 1,00 dólar por R$ 5,04 reais, em 07 de junho de 2021.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II

2.2. Título Abreviado
PROSUS II

2.3. Mutuário
Estado da Bahia

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia visa ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde na rede de atenção do estado, através do fortalecimento da atenção básica e da descentralização e regionalização das ações de média e alta complexidade.

Objetivos Específicos

Fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde da Bahia e a apoiar as tomadas de decisões através da inovação e da incorporação de soluções de tecnologia da informação na gestão hospitalar, logística, gestão de recursos humanos e modernização do parque tecnológico da SES/SE;

Apoiar o modelo de gestão das Redes de Atenção à Saúde através da capacitação de gestores e profissionais do SUS/BA;

Expandir e melhorar a oferta de serviços de atenção primária, atenção secundária e terciária nas regiões de saúde do estado;

Melhorar a oferta de serviços de apoio diagnóstico laboratorial e imunológico através do LACEN e Rede Frios;

Ampliar o acesso à rede de serviços do SUS/BA através do Núcleo de Telessaúde da Bahia;

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
População Coberta pela Atenção Básica no Estado da Bahia	% da População Estimada Coberta pela Atenção Básica	% - Percentual	76,00	93,00
Municípios com Prontuário Eletrônico do Cidadão	Nº de municípios com Prontuário Eletrônico do Cidadão x 100 / Total de Municípios no Estado	% - Percentual	20,00	50,00
Unidades da SESAB com Prontuário Eletrônico Implantado	Nº de Unidades da SESAB com Prontuário Eletrônico Implantado	Número Absoluto	8,00	32,00
Ampliação dos Serviços de Telessaúde/ Telemedicina do Estado da Bahia	Nº de Serviços de Telessaúde/ Telemedicina implantados	Número Absoluto	3,00	5,00
Número de Políclinas Regionais de Saúde do Estado	Nº de Policlínicas Regionais de Saúde do Estado	Número Absoluto	18,00	21,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	**48.500.000,00**
S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO	44.700.000,00
P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS)	40.000.000,00
P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS	4.500.000,00
P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético	200.000,00
S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA	3.800.000,00
P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades	700.000,00
P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado)	200.000,00
P - Evolução e sustentação da REDS	1.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica	1.000.000,00
P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços	400.000,00
C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**107.200.000,00**
S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE	99.600.000,00
P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde	7.400.000,00
P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia	10.000.000,00
P - Funcionamento do Hospital Metropolitano	20.000.000,00
P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas	7.500.000,00
P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões	5.500.000,00
P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado	3.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios	1.000.000,00
P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva	3.000.000,00
P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)	7.800.000,00
P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS	800.000,00
P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA)	1.600.000,00
P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA)	200.000,00
P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	18.000.000,00
P - Aquisição de Equipamentos CER	11.500.000,00
P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões	1.800.000,00
S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE	7.600.000,00
P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia	600.000,00
P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN)	3.500.000,00
P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)	2.000.000,00
P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado	1.500.000,00
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA	**14.900.000,00**
S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR	3.900.000,00
P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado	1.000.000,00
P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar	900.000,00
P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico)	2.000.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA	11.000.000,00
P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB	1.500.000,00
P - Dimensionamento da Força de Trabalho	500.000,00
P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências, Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria.	9.000.000,00
C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)	**9.400.000,00**
S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO	9.400.000,00
P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras	7.400.000,00
P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos	1.000.000,00
P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto	1.000.000,00
Total dos Componentes	**180.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

Visa a ampliação do acesso aos serviços de saúde e a resolutividade das ações da atenção básica no estado da Bahia.

S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO

Ampliação da infraestrutura da atenção básica no estado da Bahia.

P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Construção de unidades básicas de saúde tipo I,II,III e IV

P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS

Aquisição de Equipamentos de TIC (estações de trabalho: desktops, monitores, teclado, mouse ou notebooks e impressoras), além de mesas, cadeiras, macas, armários, escadas, negatoscópio e demais equipamentos e mobiliários necessários para o funcionamento de uma UBS.

P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético
Aquisição de Equipamentos para implantação de salas de pé diabético.

S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA
Ações de investimento tecnológico na atenção básica, como Prontuário Eletrônico e estruturação do parque tecnológico.

P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades
Implantação de sistema que permite o acompanhamento do histórico médico do paciente em qualquer serviço de saúde local, melhorando a coordenação do cuidado ao paciente.

P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado)
A instalação centralizador tem a função de reunir os dados de transmissão dos Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC do município, Estado ou região, fortalecendo uma organização hierárquica no fluxo da informação na esfera municipal/estadual e da produção de relatórios. A finalização da implementação do Centralizador possibilitará o acesso a dados produzidos nas Unidades Básicas de Saúde e integrá-las à REDS.

P - Evolução e sustentação da REDS
A Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS) é a plataforma estadual de interoperabilidade de dados em saúde. É um projeto estruturante para a transformação digital da saúde no estado da Bahia e tem o objetivo de promover a troca de informações entre os pontos da Rede de Atenção à Saúde, permitindo a transição e continuidade do cuidado nos setores público.

P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica
Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica como ECG, Ofltalmoscópio e Dermatoscópio.

P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços
Realização de capacitações para profissionais de saúde e gestores de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços

C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Visa o fortalecimento da infraestrutura da rede de atenção a saúde de média e alta complexidade, através de sua descentralização.

S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE
Visa fortalecer os serviços da rede de atenção a saúde de média e alta complexidade, através de reformas e aquisições de equipamentos.

P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde
Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde

P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia
Participação do estado no custeio das 18 Policlínicas nas Regiões de Saúde.

P - Funcionamento do Hospital Metropolitano
Custeio do Hospital Metropolitano

P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas
Aquisição de equipamentos, mobiliário e demais bens de uso permanente necessários para o funcionamento das Policlínicas.

P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões
Reforma/ Ampliação/ do Hospital Geral Ernesto Simões

P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado
Reforma e requalificação dos Núcleos Regionais e Rede de Frios.

P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios
Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios

P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva
Ampliação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva.

P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
Construção de Novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS
Aquisição de equipamentos mobiliário e demais bens de uso permanente necessários para os CAPS.

P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA)
Construção de Novas Unidades de Acolhimento (UA)

P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA)
Aquisição de equipamentos mobiliário e demais bens de uso permanente necessários para as Unidades de Acolhimento (UA)

P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)
Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER).

P - Aquisição de Equipamentos CER
Aquisição de equipamentos mobiliário e demais bens de uso permanente necessários para os CER.

P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões
Aquisição de Novos Hemóveis

S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE
Visa equipar e reformar unidades de atendimento de apoio a diagnóstico, como mamógrafos e os Laboratórios Regionais (Lacen).

P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia
Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia

P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN)
Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN)

P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)
Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)

P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado
Aquisição de equipamentos para os laboratórios central e regionais.

C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA
Visa fortalecer a gestão, através do uso de tecnologia da informação e certificações, possibilitando aumento na sua qualidade e eficiência.

S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR
Através de certificações, certificado digital e controle de acesso de funcionários o estado fará melhor gestão dos recursos humanos dos serviços de saúde.

P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado
Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão estadual implantados nos últimos 5 anos.

P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar
Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar

P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico)
Serviços e equipamentos para gerenciar o acesso e frequência dos profissionais de saúde e dos cidadãos, bem como gerenciar a escala dos profissionais.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA
Visa o fortalecimento institucional e melhor gestão da rede SUS Bahia através de capacitações, ampliações e consultorias.

P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB
Implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB)

P - Dimensionamento da Força de Trabalho
Estudo de dimensionamento da força de trabalho das Unidades da Rede SUS (SESAB)

P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências, Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria.
Ampliação e Qualificação de serviços de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências, Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria

C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)
Responsável por garantir apoio ao projeto através da contratação de uma gerenciadora, além de avaliação de impacto e demais consultorias necessárias.

S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
Responsável por garantir apoio ao projeto através da contratação de uma gerenciadora, além de avaliação de impacto e demais consultorias necessárias para o bom andamento da execução do projeto.

P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras
Contratação de consultores para apoio a Unidade Gestora do Programa, para o apoio a equipe da SES/SE no planejamento, execução e avaliação das ações do Programa.

P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos
Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos

P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto
Contratação de estudos de avaliação de médio prazo e do impacto gerado pelo programa

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**92.300.000,00**	**51,28**
P- Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS)	unidade	80,00	40.000.000,00	22,22
P- Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde	policlinica construida	3,00	7.400.000,00	4,11
P- Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões	Unidade hospitalar	1,00	5.500.000,00	3,06
P- Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado	nucleos regionais	9,00	3.500.000,00	1,94
P- Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva	leitos ampliados	30,00	3.000.000,00	1,67
P- Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)	unidade de CAPS	20,00	7.800.000,00	4,33
P- Construção de Unidades de Acolhimento (UA)	unidades de acolhimento	4,00	1.600.000,00	0,89
P- Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	CER construido	15,00	18.000.000,00	10,00
P- Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN)	LACEN reformado e ampliad	1,00	3.500.000,00	1,94
P- Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)	unidades novas	5,00	2.000.000,00	1,11
Bens	-	-	**30.600.000,00**	**17,00**
P- Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS	UBS equipadas	80,00	4.500.000,00	2,50
P- Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético	unidade	200,00	200.000,00	0,11
P- Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica	Grupo de equipamentos	125,00	1.000.000,00	0,56
P- Aquisição de Equipamentos Policlínicas	policlinicas equipadas	3,00	7.500.000,00	4,17
P- Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios	nucleos regionais equip	9,00	1.000.000,00	0,56
P- Aquisição de Equipamentos dos CAPS	CAPS equipados	20,00	800.000,00	0,44
P- Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA)	unidade de acolhimento eq	4,00	200.000,00	0,11
P- Aquisição de Equipamentos CER	CER equipado	15,00	11.500.000,00	6,39
P- Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões	Hemóveis adquiridos	9,00	1.800.000,00	1,00
P- Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia	Carretas adquiridas	2,00	600.000,00	0,33
P- Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado	laboratorios equipados	6,00	1.500.000,00	0,83
Consultoria	-	-	**12.800.000,00**	**7,11**
P- Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços	Profissionais capacitados	1.000,00	400.000,00	0,22
P- Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado	Unid. certificadas, acred	23,00	1.000.000,00	0,56
P- Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB	serviços c AGHUSE implant	32,00	1.500.000,00	0,83
P- Dimensionamento da Força de Trabalho	Relatorio rede SUS-SESAB	1,00	500.000,00	0,28
P- Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras	equipe apoio a UGP	1,00	7.400.000,00	4,11
P- Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos	Equipe de apoio a UGP	1,00	1.000.000,00	0,56
P- Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto	estudo	1,00	1.000.000,00	0,56
Outros	-	-	**44.300.000,00**	**24,61**
P- Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades	UBS com PEC implantado	80,00	700.000,00	0,39
P- Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado)	Centralizador implantado	1,00	200.000,00	0,11
P- Evolução e sustentação da REDS	REDS aprimorada	1,00	1.500.000,00	0,83
P- Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia	valor mensal	18,00	10.000.000,00	5,56
P- Funcionamento do Hospital Metropolitano	valor mensal	1,00	20.000.000,00	11,11

P- Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar	quantidade certificados	34.000,00	900.000,00	0,50
P- Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico)	unid com controle implant	32,00	2.000.000,00	1,11
P- Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências, Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria.	serviços implantados	5,00	9.000.000,00	5,00
Total Geral	**-**	**-**	**180.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Etapas Realizadas

Dentre as etapas já realizadas e que possibilitam a qualificação e consolidação de um projeto que atua sobre os principais problemas de comunicação, inovação tecnológica e acesso a serviços e exames especializados na saúde, ressaltamos que:

O Núcleo Técnico Científico Telessaúde Bahia foi implantado no ano de 2012, a partir do Convênio firmado entre o Governo do Estado com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Ensino e da Saúde - SGTES/MS, com o objetivo de implantar 100 (cem) pontos de Telessaúde nas Unidades Básica de Saúde, com a proposta de potencializar a qualificação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família, visando a melhoria da qualidade e resolubilidade dos serviços e cuidados em saúde. Atualmente o projeto faz parte do Programa Telessaúde Brasil Redes*, visa o melhor desenvolvimento e capacitação dos profissionais da AB, através das ofertas de Teleconsultoria, Teleducação, Telediagnóstico e Segunda Opinião Formativa (SOF), dirigidos a todas as categorias de profissionais de saúde na Atenção Básica (AB), que compõe as equipes de Saúde da Família, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, Consultório na Rua e Programa de Saúde na Escola (PSE) e possui 15.028 (quinze mil e vinte oito) profissionais cadastrados em 3.751 (três mil, setecentos e cinquenta e uma) Unidades Básicas e já realizou mais de 19 mil Teleconsultorias e atingiu 174.323 (cento e setenta e quatro mil , trezentos e vinte três) participantes ao vivo em Webpalestras.

Já as Policlínicas Regionais de Saúde estão mudando a realidade da assistência de média e alta complexidade na Bahia. Construídas em locais estratégicos no interior do estado, possibilitam descentralizar a assistência, regionalizando o atendimento ao cidadão, que passou a ter acesso aos serviços perto de casa, sem precisar se deslocar longas distâncias ou aguardar tempo excessivo para o atendimento.Para viabilizar as Policlínicas e o atendimento regional, foram criados os Consórcios Interfederativos de Saúde, que administram as unidades, com a participação do Estado no custeio do serviço e da sede do Consórcio.

Inaugurações previstas para 2021:

Brumado

Eunápolis

Itaberaba/Seabra

Ribeira do Pombal

Santa Maria da Vitória

São Francisco do Conde

Serrinha

Atualizado em março/2021

A demanda pela modernização tecnológica nas unidades de saúde cresceu exponencialmente na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB, mediante a necessidade de implantação de um sistema de gestão hospitalar, que contemplasse o prontuário eletrônico do cidadão, visando a qualificação do atendimento e a unicidade do dado. Foi estabelecido que o programa PROSUS I contemplaria a demanda de implantação do prontuário eletrônico do cidadão. O sistema que foi cedido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chamado AGHUse - Sistema de Acompanhamento e Gestão Hospitalar, para ser implantado e utilizado foram necessários diversos investimentos na área de infraestrutura das unidades de saúde apoiadas pelo citado programa. O AGHUse é um sistema completo, moderno e desenvolvido dentro de padrões internacionais de qualidade e segurança de software, de modo que possui o prontuário eletrônico e todos os módulos para gestão clínica e administrativa para as unidades de saúde. O modelo de gestão abrange os processos, as ações administrativas, os controles operacionais, os fluxos de trabalho e as análises de informações e indicadores, buscando melhorar a eficiência operacional, econômica e administrativa das unidades de saúde. Foi iniciado o processo de implantação do Prontuário nas unidades de saúde estabelecidas pelo PROSUS 1, no qual, de 2020 ao final 2021 deteremos a implantação de 8 unidades de saúde, de modo que otimizaremos toda a parte assistencial e operacional dessas unidades, gerando economicidade e mais qualidade no atendimento ao cidadão. Para as demais 24 unidades, continuaremos no processo de implantação do prontuário eletrônico - AGHUse, que está seguindo em paralelo nas 8 unidades de saúde, e já se encontra em processo de finalização. Para tanto, precisaremos do PROSUS 2 para apoiar a continuidade e finalização das 24 unidades restantes, no intuito de modernizar e abarcar a implantação para todas as unidades de Saúde do Estado da Bahia.

Em dezembro de 2014 foi firmado o Contrato de Empréstimo entre o Governo do Estado da Bahia e o BID para o Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Salvador - PROSUS. Para atingir tal objetivo realizou-se a estruturação da Atenção Integral à Saúde para superação dos vazios assistenciais em áreas prioritárias; fortaleceu-se a Regulação da Assistência à Saúde garantindo o acesso adequado dos usuários do SUS aos serviços disponibilizados na RMS; e promoveu o fortalecimento Institucional da SESAB consolidando o papel de coordenador geral do Sistema Estadual de Saúde. Essas ações se deram por meio da construção e implantação de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 13 Policlínicas de Saúde; 14 Academias da Saúde; 09 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 01 Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil (UAIJ); 01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); construção do Hospital Metropolitano, ampliação e reforma do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e do Hospital João Batista Caribé que passou a se chamar Maternidade Maria Conceição de Jesus; superando os vazios assistenciais; além de promover o fortalecimento institucional através de capacitações para toda a rede SUS da RMS e gestores da SESAB.

Apesar do PROSUS ter promovido uma melhoria no SUS para a Região Metropolitana de Salvador, haja vista que se aponta avanços, como o aumento da população cadastrada no Programa de Saúde da Família (PSF); aumento da cobertura estimada do PSF; diminuição da Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por Diabetes Mellitus e melhoria no acesso aos serviços de saúde, superando os vazios assistenciais, os desafios ainda permanecem. Os principais problemas de saúde devem ser resolvidos com a devida organização do SUS em Redes de Atenção à Saúde (RAS) coordenadas pela Atenção Primária à Saúde (APS). Avançar na definição de um modelo ideal que seja viável de ser colocado em prática e, diante disso, é importante dar continuidade às ações do PROSUS, através do PROSUS 2, para avançar nas mudanças necessárias que levem à conformação de um sistema integrado que opere de forma contínua e proativa e que seja capaz de responder, com eficiência, efetividade, qualidade e de modo equilibrado, às condições agudas e crônicas da população. Adequado para a atual situação epidemiológica e demográfica do estado.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado da Bahia ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Devido às necessidades e desafios de saúde pública aqui apresentadas pelo estado da Bahia, a possibilidade de um financiamento externo pode garantir a manutenção e ampliar o acesso à saúde de qualidade, como também mitigar dificuldades econômicas a serem enfrentadas pelo contexto atual.

Considerando que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) tem tradição na oferta a países da América Latina e Caribe a possibilidade de financiamento para melhoria da atenção à saúde das populações, o estado de Sergipe oferece este pleito, como uma estratégia para a continuidade da melhoria do SUS Sergipe.

O valor proposto do empréstimo é de US$ 150.000.000,00 com contrapartida do estado da Bahia de US$30.000.000,00.

Este projeto seguirá os Termos e Condições Financeiras Aplicáveis aos Empréstimos de Investimento com Recursos do Capital Ordinário do BID, sendo:

Carência: 5,5 anos (66 meses)

Prazo de amortização: 25 anos (máximo)

Vida Média Ponderada (VMP): 15,25 anos (máximo)

Total da taxa de juros: 2.75 % a.a. (vigente 1º trimestre de 2020)

Libor (3 meses): 1.83% (vigente 1º trimestre de 2020)

Margem do Fundo: 0.12% (vigente 1º trimestre de 2020)

Margem do empréstimo: 0.80% (vigente 1º trimestre de 2020)

Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a.

Período para amortização e Vida Média Ponderada (VMP): O vencimento de empréstimos de investimento é de no máximo 25 anos e a vida média ponderada máxima de no máximo 15,25 anos.

Períodos de Desembolso e Carência: Os empréstimos standard têm um cronograma de amortização linear, com prestações semestrais (ou trimestrais), consecutivas e na medida do possível iguais. Considerando que o período para desembolsos típico é de 5 anos contados da data de vigência do contrato de empréstimo, o período de carência típico é de 66 meses.

Taxas de juros: As taxas de juros estão baseadas na LIBOR (três meses), acrescidos dos encargos correspondentes (para a lista completa de taxas de juros e comissões aplicáveis aos produtos vigentes -capital ordinário, visite: https://www.iadb.org/en/idb-finance/interest-rates-and-loan-charges.

Moeda de referência: A moeda na qual se pretende contratar o empréstimo ora pretendido é o dólar americano, considerando a cotação do câmbio de fechamento de venda, em 07/06/2021, de R$/US$ 5,04 (U$$ 1,00=R$ 5,04), conforme informação do BACEN.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os beneficiários últimos das ações propostas nesta Carta Consulta são todos os cidadãos do estado da Bahia.

Em algumas das ações sugeridas, os próprios cidadãos também são o seu público-alvo. Em outras ações, o público-alvo são os profissionais e gestores da saúde, beneficiando indiretamente a população.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
Total:			180.000.000,00		180.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) Arranjo Institucional

O projeto será realizado pelo Governo do Estado da Bahia, através de sua Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

A secretaria formalizará, uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), que servirá como órgão de ligação entre a SESAB, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras organizações participantes.

(ii) Matriz de Responsabilidade

Vide Anexo 3- Matriz de Responsabilidade.

(iii) Arranjo Operacional

O Arranjo operacional deste programa contará com a equipe da SESAB com experiência prévia na execução de projetos com organismos internacionais, como foi o caso recente do PROSUS I.

Uma unidade de gerenciamento do programa está prevista, onde uma equipe de apoio adicional a equipe da SESAB será contratada para auxiliar no planejamento, execução e monitoramento do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Saúde do Estado da Bahia		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	**48.500.000,00**	**0,00**	**462.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO	44.700.000,00	0,00	362.000,00		
P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS)	40.000.000,00	0,00	360.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS	4.500.000,00	0,00	0,00		
P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético	200.000,00	0,00	2.000,00		
S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA	3.800.000,00	0,00	100.000,00		
P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades	700.000,00	0,00	0,00		
P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado)	200.000,00	0,00	0,00		
P - Evolução e sustentação da REDS	1.500.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica	1.000.000,00	0,00	100.000,00		
P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços	400.000,00	0,00	0,00		
C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**107.200.000,00**	**6.000.000,00**	**2.992.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE	99.600.000,00	6.000.000,00	2.392.000,00		
P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde	7.400.000,00	0,00	592.000,00		
P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
P - Funcionamento do Hospital Metropolitano	20.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas	7.500.000,00	0,00	0,00		
P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões	5.500.000,00	0,00	0,00		
P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado	3.500.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva	3.000.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)	7.800.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS	800.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA)	1.600.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA)	200.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	18.000.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos CER	11.500.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE	7.600.000,00	0,00	600.000,00		
P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia	600.000,00	0,00	600.000,00		

P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN)	3.500.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)	2.000.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado	1.500.000,00	0,00	0,00		
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA	**14.900.000,00**	**0,00**	**85.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR	3.900.000,00	0,00	0,00		
P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar	900.000,00	0,00	0,00		
P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico)	2.000.000,00	0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA	11.000.000,00	0,00	85.000,00		
P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB	1.500.000,00	0,00	75.000,00		
P - Dimensionamento da Força de Trabalho	500.000,00	0,00	10.000,00		
P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria.	9.000.000,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)	**9.400.000,00**	**0,00**	**940.000,00**		
S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO	9.400.000,00	0,00	940.000,00		
P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras	7.400.000,00	0,00	740.000,00		
P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto	1.000.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**6.000.000,00**	**4.479.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		**0,00**	**7.502.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO		0,00	6.590.000,00		
P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS)		0,00	5.840.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS		0,00	720.000,00		
P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético		0,00	30.000,00		
S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	912.000,00		
P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades		0,00	140.000,00		
P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado)		0,00	40.000,00		
P - Evolução e sustentação da REDS		0,00	300.000,00		
P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica		0,00	400.000,00		
P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços		0,00	32.000,00		
C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**6.000.000,00**	**6.625.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE		6.000.000,00	6.275.000,00		
P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde		0,00	1.480.000,00		
P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia		2.000.000,00	0,00		
P - Funcionamento do Hospital Metropolitano		4.000.000,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas		0,00	2.250.000,00		
P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões		0,00	0,00		
P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado		0,00	525.000,00		
P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios		0,00	150.000,00		
P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva		0,00	450.000,00		
P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)		0,00	390.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS		0,00	40.000,00		
P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA)		0,00	80.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA)		0,00	10.000,00		
P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)		0,00	900.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos CER		0,00	0,00		
P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões		0,00	0,00		
S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE		0,00	350.000,00		
P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia		0,00	0,00		
P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN)		0,00	175.000,00		
P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)		0,00	100.000,00		
P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado		0,00	75.000,00		
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA		**0,00**	**2.155.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR		0,00	580.000,00		
P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado		0,00	0,00		
P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar		0,00	180.000,00		
P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico)		0,00	400.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA		0,00	1.575.000,00		
P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB		0,00	375.000,00		
P - Dimensionamento da Força de Trabalho		0,00	300.000,00		

P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria.		0,00	900.000,00		
C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)		**0,00**	**1.965.000,00**		
S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO		0,00	1.965.000,00		
P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras		0,00	1.665.000,00		
P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos		0,00	200.000,00		
P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**6.000.000,00**	**18.247.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		**0,00**	**18.830.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO		0,00	17.370.000,00		
P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS)		0,00	15.490.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS		0,00	1.800.000,00		
P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético		0,00	80.000,00		
S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.460.000,00		
P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades		0,00	245.000,00		
P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado)		0,00	70.000,00		
P - Evolução e sustentação da REDS		0,00	525.000,00		
P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica		0,00	500.000,00		
P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços		0,00	120.000,00		
C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**6.000.000,00**	**29.920.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE		6.000.000,00	26.770.000,00		
P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde		0,00	2.960.000,00		
P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia		2.000.000,00	0,00		
P - Funcionamento do Hospital Metropolitano		4.000.000,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas		0,00	2.625.000,00		
P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões		0,00	1.650.000,00		
P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado		0,00	1.400.000,00		
P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios		0,00	400.000,00		
P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva		0,00	1.200.000,00		
P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)		0,00	3.120.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS		0,00	320.000,00		
P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA)		0,00	640.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA)		0,00	80.000,00		
P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)		0,00	7.200.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos CER		0,00	5.175.000,00		
P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões		0,00	0,00		
S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE		0,00	3.150.000,00		
P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia		0,00	0,00		
P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN)		0,00	1.575.000,00		
P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)		0,00	900.000,00		
P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado		0,00	675.000,00		
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA		**0,00**	**4.800.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR		0,00	1.310.000,00		
P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado		0,00	150.000,00		
P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar		0,00	360.000,00		
P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico)		0,00	800.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA		0,00	3.490.000,00		
P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB		0,00	600.000,00		
P - Dimensionamento da Força de Trabalho		0,00	190.000,00		
P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria.		0,00	2.700.000,00		
C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)		**0,00**	**2.165.000,00**		
S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO		0,00	2.165.000,00		
P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras		0,00	1.665.000,00		
P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos		0,00	200.000,00		
P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto		0,00	300.000,00		
Total	**0,00**	**6.000.000,00**	**55.715.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		**0,00**	**17.237.000,00**		

S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO		0,00	16.245.000,00		
P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS)		0,00	14.600.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS		0,00	1.575.000,00		
P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético		0,00	70.000,00		
S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	992.000,00		
P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades		0,00	231.000,00		
P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado)		0,00	66.000,00		
P - Evolução e sustentação da REDS		0,00	495.000,00		
P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica		0,00	0,00		
P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços		0,00	200.000,00		
C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**6.000.000,00**	**31.775.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE		6.000.000,00	28.275.000,00		
P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde		0,00	1.850.000,00		
P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia		2.000.000,00	0,00		
P - Funcionamento do Hospital Metropolitano		4.000.000,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas		0,00	1.500.000,00		
P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões		0,00	2.750.000,00		
P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado		0,00	1.575.000,00		
P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios		0,00	450.000,00		
P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva		0,00	1.350.000,00		
P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)		0,00	3.540.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS		0,00	440.000,00		
P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA)		0,00	880.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA)		0,00	90.000,00		
P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)		0,00	8.100.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos CER		0,00	5.750.000,00		
P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões		0,00	0,00		
S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE		0,00	3.500.000,00		
P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia		0,00	0,00		
P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN)		0,00	1.750.000,00		
P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado		0,00	750.000,00		
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA		**0,00**	**6.260.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR		0,00	1.460.000,00		
P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado		0,00	500.000,00		
P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar		0,00	360.000,00		
P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico)		0,00	600.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA		0,00	4.800.000,00		
P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB		0,00	300.000,00		
P - Dimensionamento da Força de Trabalho		0,00	0,00		
P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria.		0,00	4.500.000,00		
C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)		**0,00**	**2.165.000,00**		
S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO		0,00	2.165.000,00		
P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras		0,00	1.665.000,00		
P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos		0,00	200.000,00		
P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto		0,00	300.000,00		
Total	**0,00**	**6.000.000,00**	**57.437.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		**0,00**	**4.469.000,00**	**0,00**	**48.500.000,00**
S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO		0,00	4.133.000,00	0,00	44.700.000,00
P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS)		0,00	3.710.000,00	0,00	40.000.000,00
P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS		0,00	405.000,00	0,00	4.500.000,00
P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético		0,00	18.000,00	0,00	200.000,00
S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	336.000,00	0,00	3.800.000,00
P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades		0,00	84.000,00	0,00	700.000,00
P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado)		0,00	24.000,00	0,00	200.000,00
P - Evolução e sustentação da REDS		0,00	180.000,00	0,00	1.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços		0,00	48.000,00	0,00	400.000,00
C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**6.000.000,00**	**5.888.000,00**	**30.000.000,00**	**77.200.000,00**
S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE		6.000.000,00	5.888.000,00	30.000.000,00	69.600.000,00

P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde		0,00	518.000,00	0,00	7.400.000,00
P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia		2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
P - Funcionamento do Hospital Metropolitano		4.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas		0,00	1.125.000,00	0,00	7.500.000,00
P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões		0,00	1.100.000,00	0,00	5.500.000,00
P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)		0,00	750.000,00	0,00	7.800.000,00
P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS		0,00	0,00	0,00	800.000,00
P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA)		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA)		0,00	20.000,00	0,00	200.000,00
P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)		0,00	1.800.000,00	0,00	18.000.000,00
P - Aquisição de Equipamentos CER		0,00	575.000,00	0,00	11.500.000,00
P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE		0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia		0,00	0,00	0,00	600.000,00
P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN)		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA		**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**14.900.000,00**
S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR		0,00	550.000,00	0,00	3.900.000,00
P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado		0,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00
P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar		0,00	0,00	0,00	900.000,00
P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico)		0,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA		0,00	1.050.000,00	0,00	11.000.000,00
P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB		0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
P - Dimensionamento da Força de Trabalho		0,00	0,00	0,00	500.000,00
P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria.		0,00	900.000,00	0,00	9.000.000,00
C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)		**0,00**	**2.165.000,00**	**0,00**	**9.400.000,00**
S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO		0,00	2.165.000,00	0,00	9.400.000,00
P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras		0,00	1.665.000,00	0,00	7.400.000,00
P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto		0,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	**180.000.000,00**	**6.000.000,00**	**14.122.000,00**	**30.000.000,00**	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para que seja iniciada a implementação do Programa, deverá ser elaborada e submetidos à Assembleia Legislativa Lei autorizativa para obtenção de empréstimo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Os recursos para contratações dos serviços que serão implantados, como Unidades Básicas de Saúde são viabilizados pela Política Nacional de Atenção Básica e o Incentivo Financeiro Estadual para a Estratégia de Estruturação da Rede de Atenção à Saúde, bem como os Serviços de Reabilitação e Atenção Psicossocial recebem financiamento das Políticas Respectivas constantes na Portaria de Consolidação nº 6 de 28 de setembro de 2017.

Já as Policlínicas Regionais de Saúde, estas fazem parte do Consórcio Inter federativo de Saúde, o qual o Estado faz parte e rateia 40 % do custeio dos Serviços.

Quanto aos serviços relativos ao Telessaúde, vale ressaltar que o Estado da Bahia possui o Núcleo Técnico Científico funcionando desde 2013, com profissionais do próprio quadro de Servidores Estatutários, complementado com servidores do quadro da Fundação Estatal Saúde da Família, mediante Contrato de Programa.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A aplicação da legislação ambiental pertinente visa assegurar que os investimentos sejam ambientalmente e socialmente sustentáveis, e que, dessa forma, possam contribuir para atingir os objetivos do Programa e assim, os níveis esperados de eficácia, eficiência e efetividade dos projetos financiados.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não existe um impacto social do Programa que possa interferir negativamente na saúde da população do estado, muito menos em populações vulneráveis como populações indígenas, quilombolas, entre outras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 13/12/2022: O pleito relativo ao "Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II" foi retirado de pauta na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25 de outubro de 2022, a pedido do Estado por meio do Ofício GAB nº172/2022, de 20 de outubro de 2022. O pleito será reapreciado na próxima reunião de deliberação.